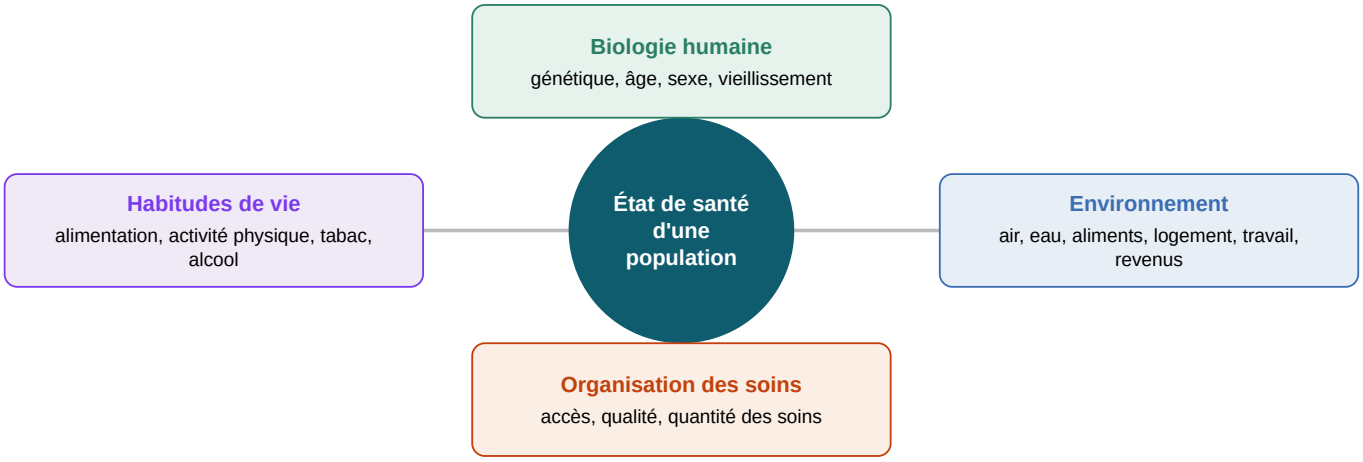
# Les schémas du chapitre 2 à savoir refaire

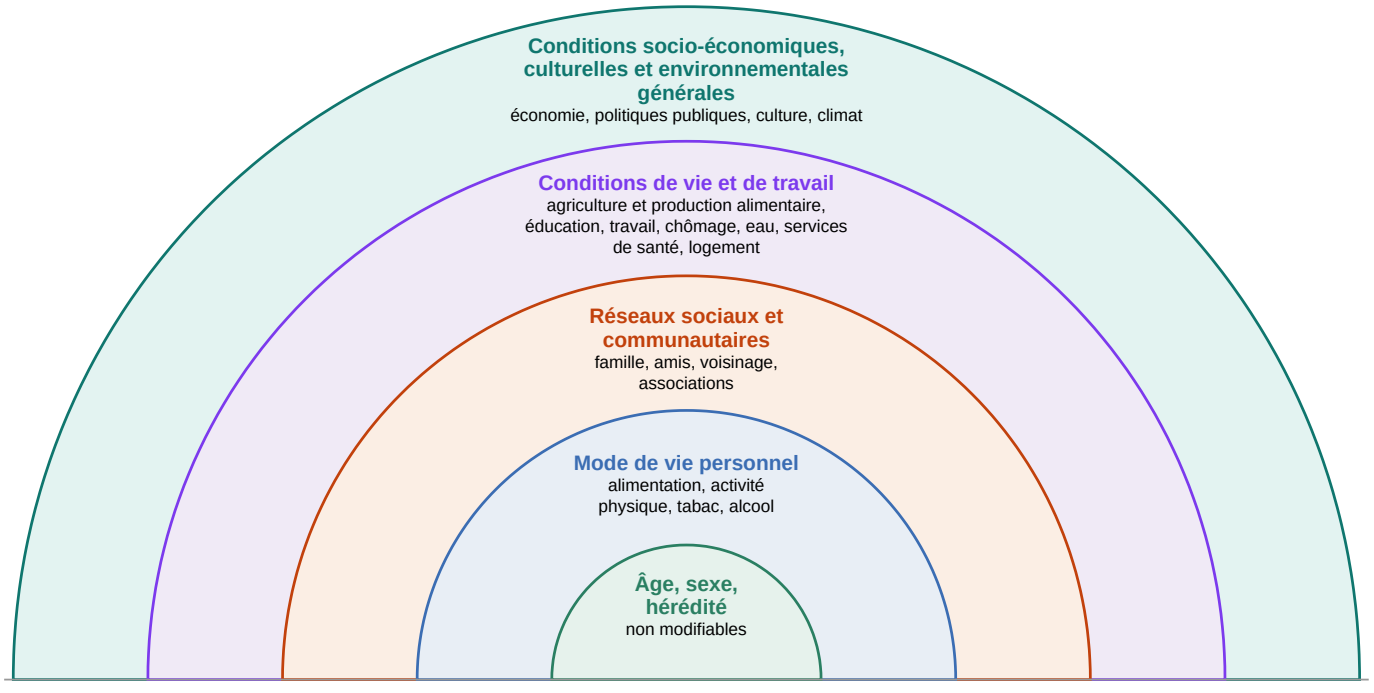
15 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

## 1. Le champ de la santé de Lalonde (1974) (2.3.1, figures 2.1 et 2.1 ter)




Dire : 4 champs de même taille, juxtaposés ; le rapport Lalonde (Canada) montrait que presque toutes les dépenses allaient aux soins alors que les 3 autres champs pèsent plus sur la mortalité. Limite : risque de culpabiliser l'individu (« habitudes de vie »).

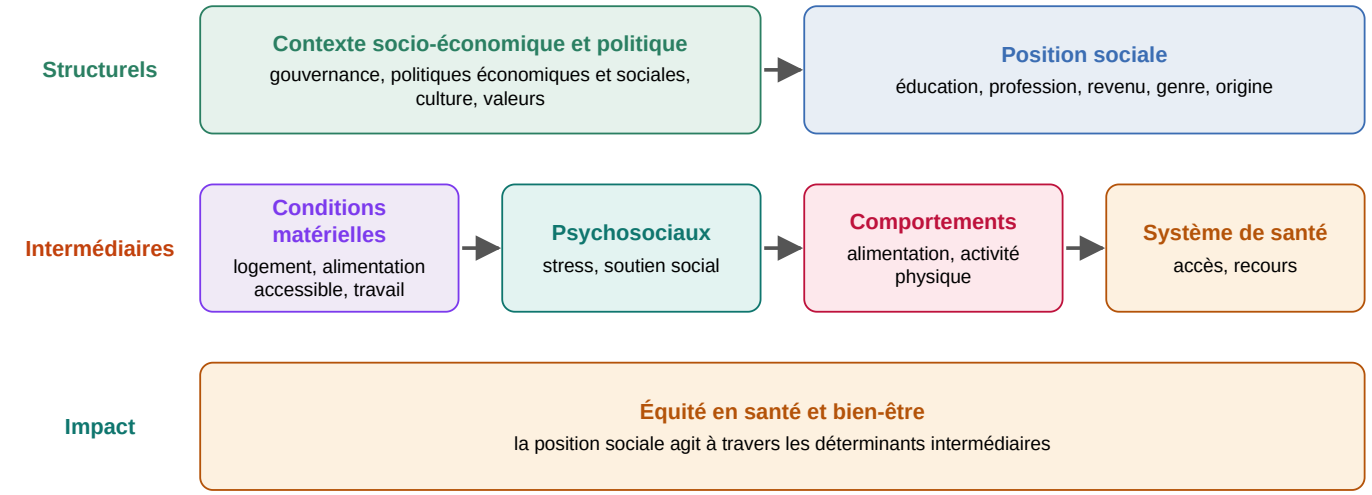
## 2. Le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991) (2.3.1, figure 2.1 bis)




*plus on agit sur une couche extérieure, plus l'action touche de personnes et moins elle dépend de la volonté de chacun*

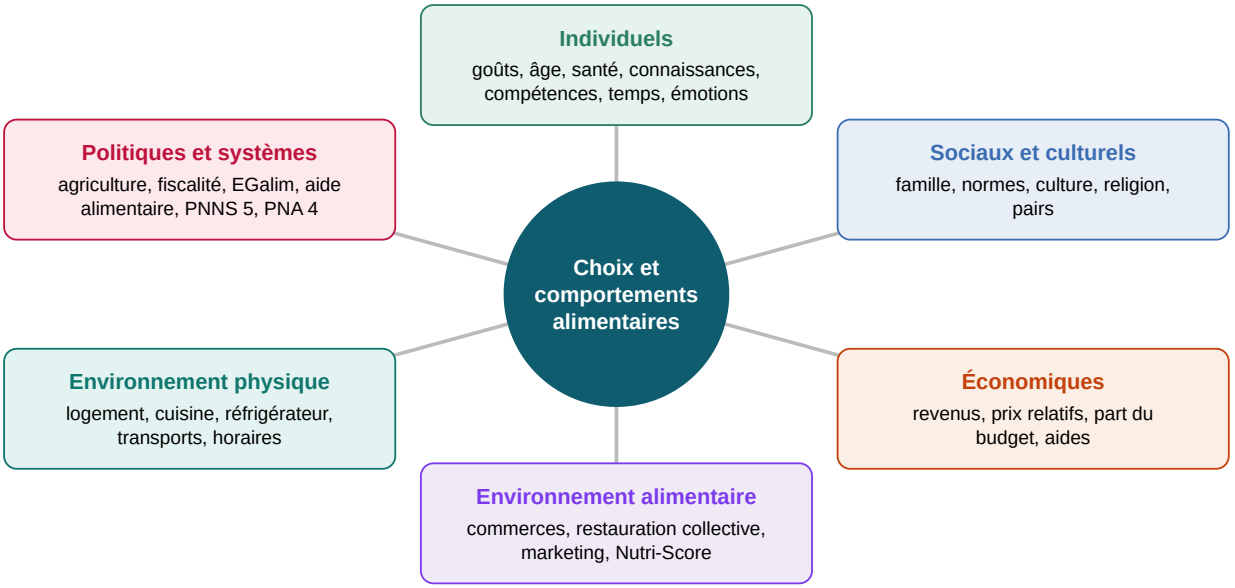
Dire : 5 couches de l'intérieur vers l'extérieur ; les comportements sont enchâssés dans les conditions de vie. Le modèle sert à analyser les déterminants d'un public ET à choisir le niveau d'action. Limite : ne montre pas les liens de cause entre couches.

## 3. Le cadre des déterminants sociaux de la santé (CDSS de l'OMS, 2008) (2.3.1, figure 2.2 ; Solar et Irwin, 2010)



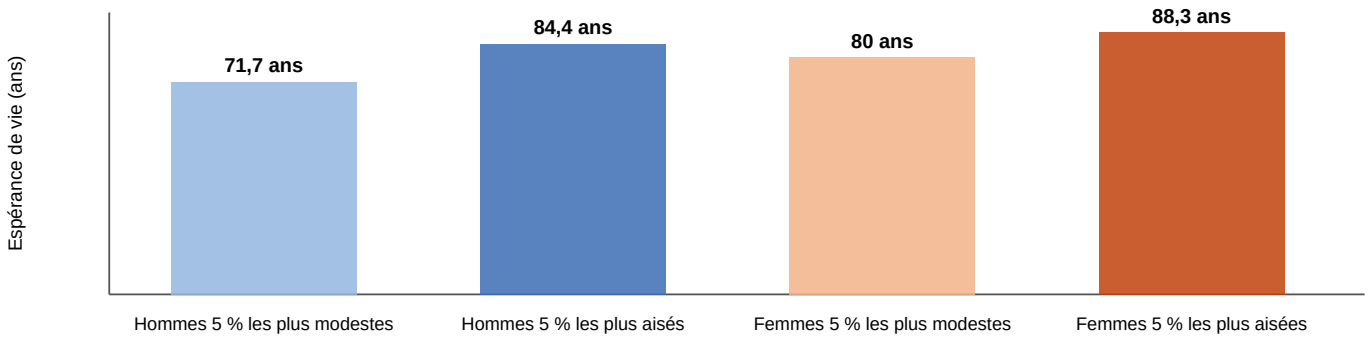

Dire : les déterminants structurels produisent la stratification sociale, donc les inégalités ; ils agissent sur la santé à travers les déterminants intermédiaires. Conséquence : agir sur les seuls comportements ne corrige pas les inégalités ; il faut aussi agir sur les conditions de vie et les politiques.

## 4. Les déterminants des choix alimentaires (2.3.1, figure 2.3)



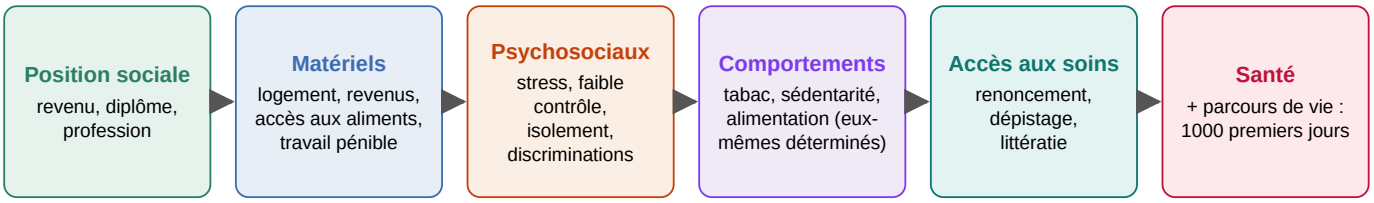

Dire les 6 familles et rappeler : désert alimentaire (accès physique difficile au frais) ≠ marais alimentaire (saturé de restauration rapide). Méthode O2.1 : problème sans jugement → recueil → freins ET ressources → leviers et qui agit.

## 5. Le gradient social : espérance de vie selon le niveau de vie (2.3.2, figures 2.4 et 2.4 bis ; Insee, 2018)




Dire : ≈ 13 ans d'écart chez les hommes, ≈ 8 ans chez les femmes (Insee 2018, données 2012-2016). L'espérance de vie augmente à chaque échelon : c'est une pente, pas une marche → une action réservée aux plus pauvres oublie le gradient, une action identique pour tous profite aux plus aisés : universalisme proportionné.

## 6. Les mécanismes des inégalités sociales de santé (2.3.2 ; rapport Black, 1980)

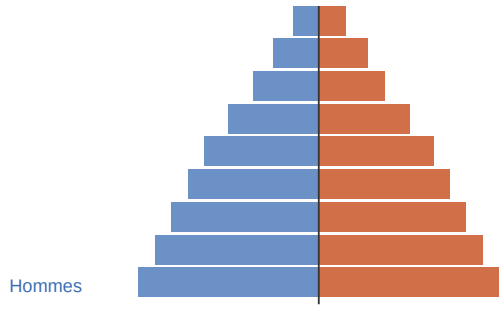



*Rapport Black : artefact (rejeté), sélection par la santé (faible), culturel (partiel), matérialiste et structurel (principal)*

Dire la chaîne explicative complète et ne jamais réduire l'écart aux « mauvais choix » : « les personnes modestes sont plus souvent obèses parce que… prix par calorie, offre du quartier, horaires, stress, équipement, littératie ».

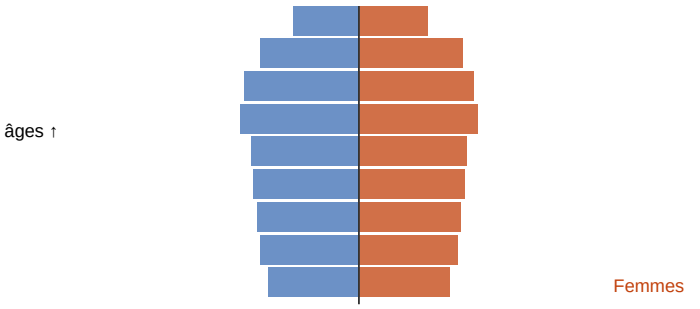
## 7. Lire une pyramide des âges (2.3.3, figures 2.5 et 2.5 bis)

**Triangle : population jeune**




natalité élevée, espérance de vie courte

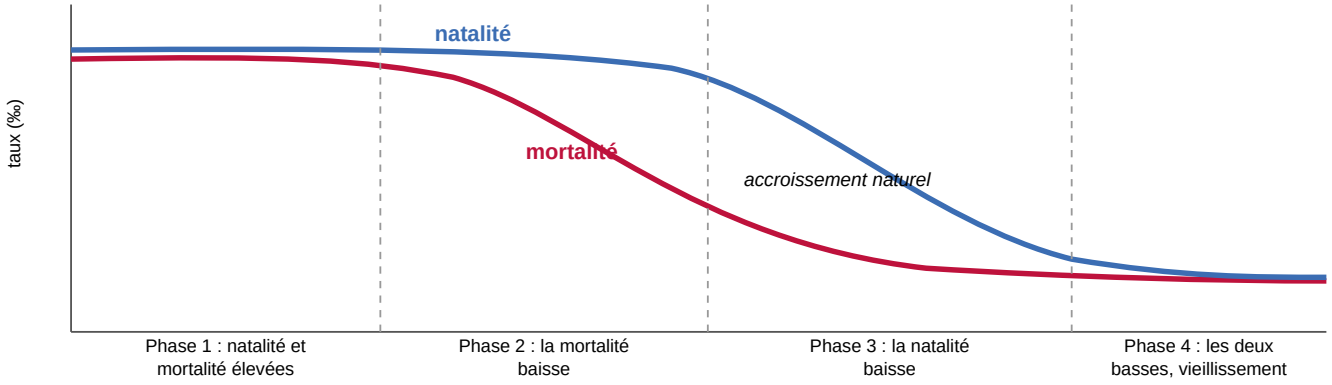
**Meule : population vieillissante (France)**




base étroite (natalité ↓), renflement baby-boom, sommet plus large côté femmes

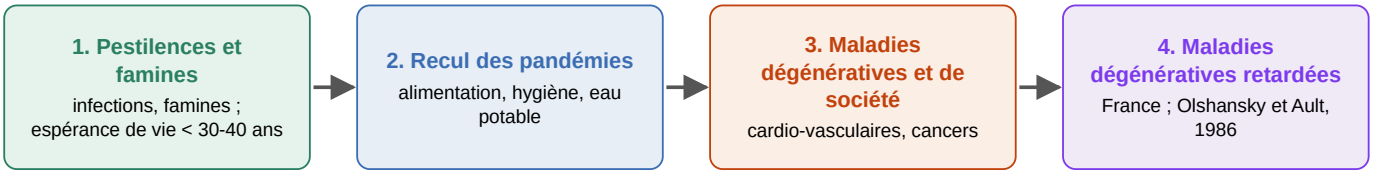
Commenter en 5 étapes : présenter (territoire, date, source, unité) → forme (triangle, cloche, meule) → anomalies (classes creuses, renflement du baby-boom 1946-1975, étudiants, déséquilibre H/F) → chiffrer (moins de 20 ans, 65 ans ou plus, indice de vieillissement) → conclure pour l'action (petite enfance ou bien vieillir).

## 8. La transition démographique (2.3.7, figure 2.9)




Dire les 4 phases ; l'accroissement naturel (écart entre les courbes) est maximal en phase 2. La France est en phase 4 : solde naturel négatif en 2025 (− 6 000), croissance par le solde migratoire. Relier aux transitions épidémiologique (Omran 1971) et nutritionnelle (Popkin 1993).

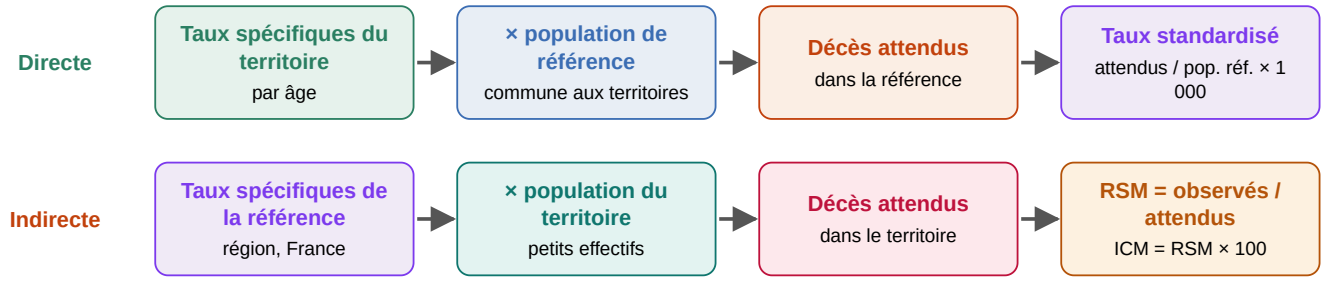
## 9. Les âges de la transition épidémiologique (Omran, 1971) (2.3.7)




*Nutrition : lutte contre les carences (âges 1-2) → contre les excès et la dénutrition des âgés (âges 3-4) ; double fardeau*

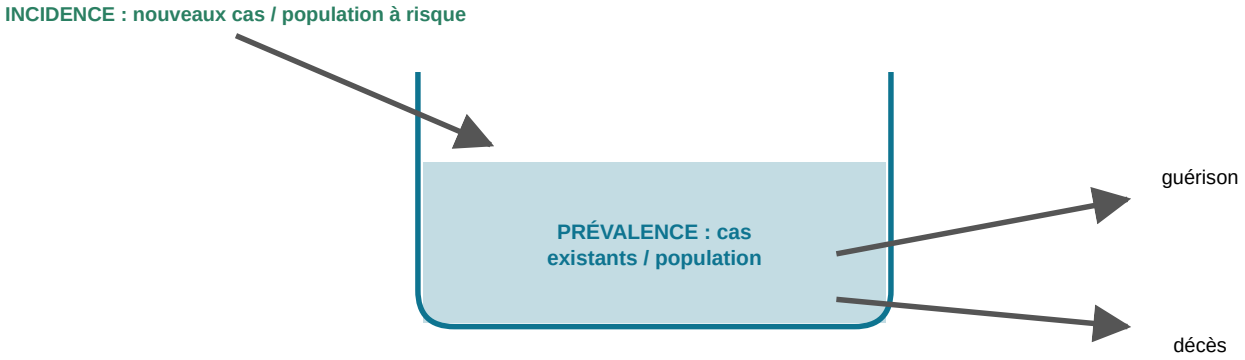
Dire : les maladies chroniques causent ≈ 74 % des décès dans le monde (OMS 2023). Transition nutritionnelle (Popkin 1993) : plus de produits animaux, sucres, graisses, aliments transformés, moins d'activité physique.

## 10. Standardisation directe et indirecte (2.3.4, figure 2.5 ter)




Dire : on ne compare jamais deux territoires avec des taux bruts (effet de l'âge). Directe = effectifs suffisants ; indirecte = petits territoires (ORS). ICM 120 = 20 % de décès en plus à âge égal ; vérifier l'intervalle (D ± 1,96 √D) ; ne pas comparer deux RSM entre eux.

## 11. Prévalence et incidence : l'image de la baignoire (2.3.4)




*prévalence ≈ incidence × durée · primaire ↓ incidence · secondaire ↓ durée*

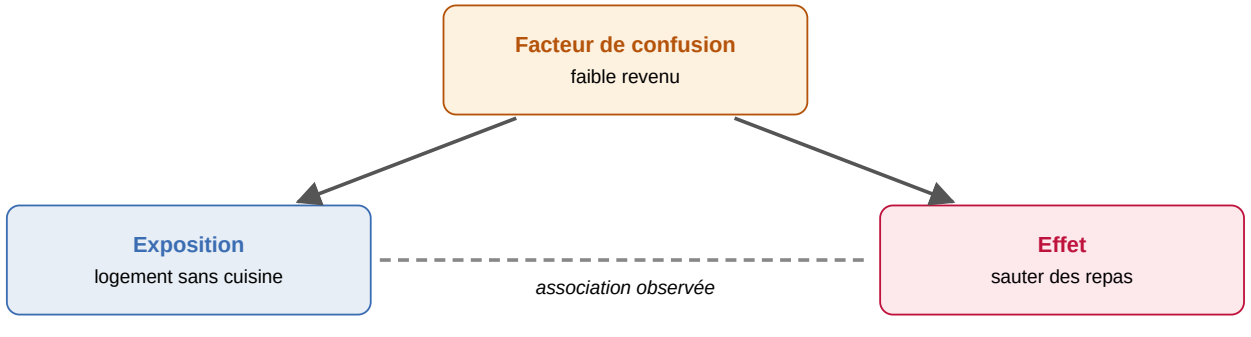
Dire : la prévalence (stock) se calcule sur toute la population ; l'incidence (flux d'entrée) sur la population à risque, sans les malades. Diabète de type 2 : peu incident mais long → prévalence forte. Taux d'incidence en personnes-années si les durées de suivi diffèrent.

## 12. Le tableau de contingence 2 × 2 et les mesures d'association (2.3.9, figure 2.10)

| | Malades | Non malades | Mesure |
|---|---|---|---|
| **Exposés** | a = 36 | b = 164 | R1 = a / (a + b) = 18 % |
| **Non exposés** | c = 30 | d = 270 | R0 = c / (c + d) = 10 % |
| **Risque relatif** | RR = R1 / R0 = 1,8 | Différence de risques | DR = R1 − R0 = 8 points |
| **Odds ratio** | OR = ad / bc = 1,98 | Fraction attribuable (exposés) | (RR − 1) / RR = 44 % |

Dire : RR = 1 pas d'association ; > 1 facteur de risque ; < 1 protecteur (0,6 = risque 40 % plus faible). OR ≈ RR si la maladie est rare (cas-témoins). Une association n'est pas une causalité : confusion, biais, temporalité (Bradford Hill).

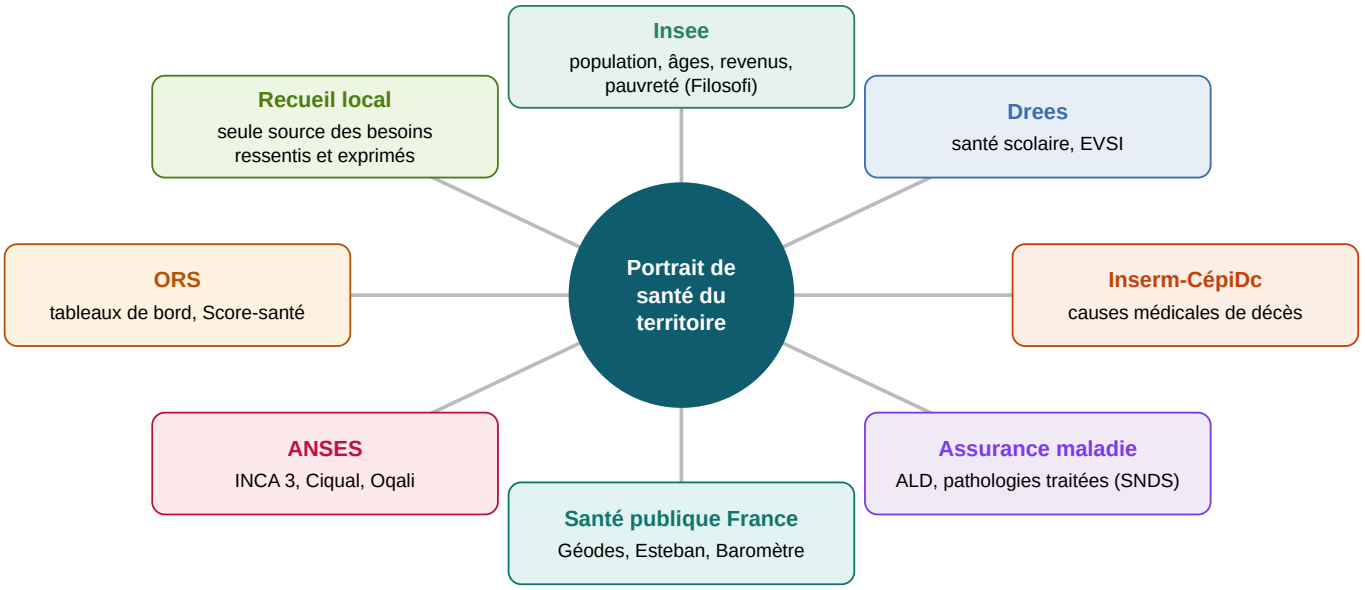
## 13. Le facteur de confusion (2.3.9, figure 2.10 bis)




*contrôle : stratifier (comparer à revenu égal) ou ajuster*

Dire : un facteur de confusion est lié à la fois à l'exposition et à l'effet ; il crée ou masque une association. Autres pièges : biais de sélection, biais d'information, causalité inverse. Seul argument de Bradford Hill indispensable : la temporalité.

## 14. Les sources d'un portrait de santé de territoire (2.3.5, figure 2.6 bis)




Dire les 6 étapes : délimiter → démographie → social → santé → déterminants et ressources → comparer à une référence, dater, sourcer, rédiger 3 à 5 constats (fiche F1). Toujours distinguer données locales et nationales, mesurées et déclarées.

## 15. Choisir le niveau d'action : des déterminants aux leviers (2.3.13)

| Niveau (Dahlgren et Whitehead) | Levier en nutrition | Acteurs |
|---|---|---|
| **Facteurs individuels** | non modifiables : servent à cibler | – |
| **Comportements** | ateliers, éducation nutritionnelle, Nutri-Score | diététiciens, éducateurs |
| **Réseaux** | repas partagés, mamans relais, jardins partagés | centres sociaux, associations |
| **Conditions de vie et de travail** | cantine, épicerie solidaire, logement équipé | collectivités, employeurs, CCAS |
| **Conditions générales** | minima sociaux, taxe soda, publicité, PAT | État, UE, collectivités |

Dire : plus on agit à l'extérieur, plus l'action touche de monde et moins elle dépend de la volonté individuelle. Outils : évaluation d'impact sur la santé (EIS), santé dans toutes les politiques (Helsinki 2013), cadre NOURISHING (WCRF 2013), grille de priorisation pondérée.